

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Apostila de Estudo · SESSÃO 12

Cirurgia Pediátrica

*Vômitos do recém-nascido, abdome agudo da criança,
icterícia cirúrgica, defeitos de parede, virilha e genitais*



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental

UniBH Vespasiano

8º PERÍODO · 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

SUMÁRIO

Reconhecer a urgência, estabilizar e chamar o cirurgião pediátrico na hora certa

I	O recém-nascido e o lactente que vomitam	3
	<i>Bilioso × não bilioso, estenose do piloro, atresias de esôfago e duodeno, má rotação com volvo</i>	
II	Obstrução baixa e enterocolite necrosante	5
	<i>Hirschsprung, anomalia anorretal, enterocolite do prematuro</i>	
III	Dor abdominal aguda na criança	6
	<i>Intussuscepção e apendicite</i>	
IV	Icterícia que é cirúrgica	7
	<i>Atresia de vias biliares e cisto de colédoco</i>	
V	Defeitos da parede e do diafragma	8
	<i>Gastrosquise × onfalocele, hérnia diafragmática congênita</i>	
VI	Virilha, umbigo e genitais	10
	<i>Hérnia inguinal, hidrocele, hérnia umbilical, criptorquidia, fimose, hipospádia, escroto agudo</i>	
VII	Armadilhas e sequência mental	12
—	Pontos clássicos de prova	13
	<i>Epônimos, sinais e números que ainda caem</i>	
—	Referências e créditos das imagens	14

COMO LER ESTA APOSTILA

CAI NA PROVA

O que costuma ser cobrado ou confundido.

CONDUTA

O passo a passo do que fazer.

ATENÇÃO

Armadilha clínica ou mudança recente.

CAPÍTULO I

O recém-nascido e o lactente que vomitam

A primeira pergunta é a cor do vômito. Vômito verde (bilioso) no recém-nascido é obstrução abaixo da papila até prova em contrário, e a má rotação com volvo não pode esperar.

TABELA 1. O vômito aponta o nível da obstrução

VÔMITO	PENSE EM	PISTA
Não bilioso, em jato, aos 2–8 semanas	Estenose hipertrófica do piloro	Bebê faminto logo depois de vomitar; "oliva" palpável
Saliva espumosa desde o nascimento, engasgo ao mamar	Atresia de esôfago	A sonda não desce: para a cerca de 10 cm da gengiva
Bilioso nas primeiras horas, abdome pouco distendido	Atresia duodenal; má rotação com volvo	Dupla bolha; síndrome de Down na atresia
Bilioso com abdome muito distendido	Obstrução baixa: atresia jejunoileal, íleo meconial, Hirschsprung	Atraso na eliminação do mecônio

Estenose hipertrófica do piloro

O músculo do piloro hipertrofia e fecha a saída do estômago. Aparece entre **2 e 8 semanas**, mais em meninos primogênitos. O vômito é **não bilioso, em jato**, piora a cada dia, e o bebê continua com fome. Ao exame, onda peristáltica visível e, às vezes, a "oliva" no epigástrico. A perda de suco gástrico causa **alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica**.

Diagnóstico: ultrassonografia. Músculo pilórico com espessura de 3–4 mm ou mais e canal com 15–18 mm ou mais de comprimento confirmam; em bebês muito pequenos, valores limítrofes pedem correlação clínica.



FIGURA 1. Piloro alongado e espesso (seta), com 6 semanas.

Dr Laughlin Dawes, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

CONDUTA · NÃO É URGÊNCIA CIRÚRGICA

É urgência **clínica**. Primeiro corrija a desidratação com soro fisiológico e glicose, acrescentando potássio quando houver diurese; só com água, cloreto e bicarbonato **normalizados** a criança vai para a **piloromiotomia** (Fredet-Ramstedt), aberta ou laparoscópica. Operar com alcalose aumenta o risco de apneia na anestesia.

Atresia de esôfago

Suspeito já na gestação (**polidrâmnio**) e na sala de parto: salivação espumosa, engasgo, tosse e cianose na primeira mamada. A sonda orogástrica não progride e, na radiografia, aparece **enrolada no coto superior**. Ar no estômago indica fístula traqueoesofágica distal: é o tipo mais comum (**tipo C**, cerca de 85%). Abdome sem ar sugere atresia sem fístula distal. Procure as anomalias da associação **VACTERL** (vértebras, ânus, coração, traqueia e esôfago, rins, membros).

CONDUTA · ATRESIA DE ESÔFAGO

Não alimentar. Cabeceira elevada e **sonda de duplo lúmen (Replogle) em aspiração contínua** no coto superior, para evitar aspiração de saliva. Ecocardiograma (o arco aórtico define o lado da toracotomia). Correção: ligadura da fístula e anastomose do esôfago, em geral por toracotomia direita.

Atresia duodenal

Vômitos nas primeiras horas, em geral **biliosos** (a obstrução costuma ficar abaixo da papila), com abdome superior distendido e o inferior escavado. Cerca de um terço tem **síndrome de Down**. A radiografia mostra a **dupla bolha**: estômago e bulbo duodenal cheios de ar, sem gás no restante do intestino. Tratamento: sonda gástrica, hidratação e **duodenoduodenostomia** eletiva.



FIGURA 2. *Atresia duodenal: estômago e bulbo duodenal muito distendidos ("dupla bolha") e nenhum gás no restante do abdome.*

Hellerboff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

ATENÇÃO · MÁ ROTAÇÃO COM VOLVO

Na má rotação, o intestino fica preso por uma base estreita e pode torcer em volta da artéria mesentérica superior: **todo o intestino médio fica isquêmico** em poucas horas. O sinal é o **vômito bilioso**, às vezes com o abdome ainda plano. Radiografia normal não exclui. Se a criança estiver estável, o exame é a **seriografia gastroduodenal** (o duodeno não cruza a linha média; "saca-rolhas" no volvo). Se estiver instável, ou com peritonite, vai direto para a cirurgia de **Ladd**.

CAPÍTULO II

Obstrução baixa e enterocolite necrosante

Quase todo recém-nascido a termo elimina mecônio nas primeiras 24 horas, e praticamente todos até 48 horas. Atraso, distensão e vômitos pedem investigação.

Doença de Hirschsprung

Faltam células ganglionares na parede do reto, e o segmento afetado não relaxa: funciona como obstrução. Em geral, o retossigmoide; mais em meninos e na síndrome de Down. Suspeite no recém-nascido com **atraso na eliminação do mecônio**, distensão e vômitos, ou na criança maior com constipação desde o nascimento. O toque retal pode provocar saída **explosiva** de fezes e gases. O enema contrastado mostra a **zona de transição** (reto estreito, cólon dilatado acima), mas o diagnóstico é a **biópsia retal** por sucção: ausência de células ganglionares. Tratamento: abaixamento do cólon normal (via transanal ou abdominal).

ATENÇÃO · ENTEROCOLITE ASSOCIADA AO HIRSCHSPRUNG

Febre, distensão e diarreia explosiva e fétida, antes ou depois da cirurgia: **enterocolite**, a principal causa de morte da doença. Hidratação, antibiótico e irrigações retais.

Anomalia anorretal

O ânus não está no lugar ou não existe. Examine o **períneo** de todo recém-nascido. Fístula visível no períneo permite a correção primária (anoplastia). Sem fístula visível, aguarde **24 horas**: o mecônio pode aparecer no períneo ou na urina (fístula urinária, no menino). Se nada aparecer, uma radiografia em perfil com o quadril elevado (ou ultrassom do períneo) mede a distância do fundo do reto à pele: perto (menos de cerca de 1 cm), correção primária; longe, **colostomia** e correção depois. Investigue VACTERL.

Enterocolite necrosante

É a urgência cirúrgica mais comum do **prematureiro**, em geral depois do início da dieta. Distensão, resíduo gástrico bilioso, sangue nas fezes, apneia e instabilidade. A radiografia mostra **pneumatose intestinal** (ar na parede das alças) e, nos casos graves, gás na veia porta e **pneumoperitônio**.



FIGURA 3. *Pneumatose intestinal e gás no fígado.*

Hellerboff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

CONDUTA · ENTEROCOLITE NECROSANTE

Suspender a dieta, sonda gástrica aberta, antibiótico venoso de amplo espectro, nutrição parenteral e radiografias seriadas. **Pneumoperitônio** (perfuração) ou piora apesar do tratamento: cirurgia (laparotomia ou drenagem peritoneal no prematuro extremo).

CAPÍTULO III

Dor abdominal aguda na criança

Intussuscepção

Um segmento do intestino entra no seguinte, como um telescópio; quase sempre o íleo entra no cólon (**ileocólica**). Pico entre 3 meses e 3 anos, sobretudo no primeiro ano, muitas vezes depois de uma virose (hipertrofia linfoide). O quadro típico são **crises de choro e dor em cólica**, com as pernas encolhidas, separadas por períodos em que a criança fica bem ou prostrada; vômitos; massa "em salsicha" no abdome. As fezes em "geleia de framboesa" são tardias: não espere por elas.

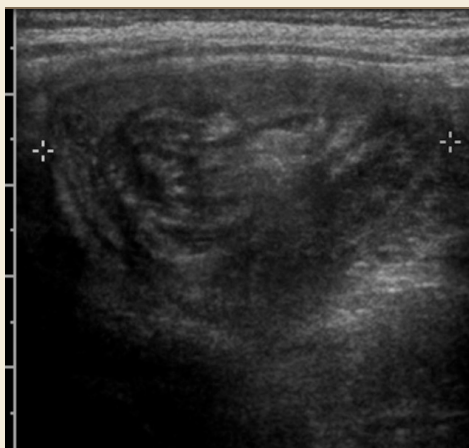


FIGURA 4. Ultrassom em corte transversal: sinal do **alvo**, os anéis concêntricos das paredes do intestino invaginado.

Frank Gaillard, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

CONDUTA · INTUSSUSCEPÇÃO

Ultrassom para diagnosticar. Hidratação e sonda gástrica. Criança estável e sem peritonite: **redução por enema** com ar ou líquido, guiada por imagem, que resolve a maioria. **Cirurgia** se houver peritonite, perfuração, choque ou falha da redução. Acima de 3 anos ou com recorrência, procure uma causa (divertículo de Meckel, pólipos, linfoma).

Apendicite na criança

É a urgência cirúrgica abdominal mais comum da infância. Quanto menor a criança, mais atípico o quadro e mais frequente a **perfuração**: abaixo de 5 anos, muitas chegam já perfuradas, porque não localizam a dor e o omento é curto. Use um escore clínico (como o Pediatric Appendicitis Score) para estratificar o risco. No risco intermediário, o primeiro exame é o **ultrassom**, para poupar radiação; ultrassom inconclusivo não encerra a investigação (reavalie ou faça ressonância ou TC). Confirmada a apendicite: jejum, hidratação, analgesia, antibiótico e **apendicectomia**; antibiótico isolado é opção só em casos não complicados selecionados.

CAI NA PROVA

Lactente com crises de choro intermitentes e vômitos: **intussuscepção**, ultrassom e redução por enema. Peritonite contraindica o enema. Criança pequena com "gastroenterite" que não melhora e dor que localiza: pense em **apendicite perfurada**.

CAPÍTULO IV

Icterícia que é cirúrgica

Icterícia que persiste além de 2 semanas (3 semanas no bebê amamentado), ou que volta, pede a dosagem da bilirrubina direta. **Fezes claras, em qualquer idade, pedem avaliação imediata:** colestase com acolia é atresia de vias biliares até prova em contrário.

Atresia de vias biliares

As vias biliares fora do fígado sofrem um processo inflamatório e obliterante, e a bile não chega ao intestino. O bebê nasce bem e, nas primeiras semanas, mantém **icterícia por bilirrubina direta, fezes claras (acolia)**, urina escura (colúria) e fígado aumentado. Sem tratamento, evolui para cirrose biliar e morte nos primeiros anos.

TABELA 2. Do sinal ao tratamento

ETAPA	O QUE FAZER
<i>Rastreo</i>	Olhar a cor das fezes em todas as consultas; a Caderneta da Criança traz uma escala de cores das fezes para os pais compararem
<i>Laboratório</i>	Bilirrubina total e direta: colestase quando a direta está elevada (acima de cerca de 1 mg/dL)
<i>Ultrassom</i>	Vesícula ausente, pequena ou irregular; "sinal do cordão triangular" no hilo hepático
<i>Confirmação</i>	Colangiografia intraoperatória e biópsia hepática
<i>Tratamento</i>	Portoenterostomia de Kasai o mais cedo possível: os melhores resultados são antes de 30–45 dias. Depois de 60 dias o resultado piora, mas isso não impede a cirurgia
<i>Se falhar</i>	Transplante hepático; a atresia é a principal indicação de transplante de fígado na criança

ATENÇÃO · O TEMPO É O TRATAMENTO

O erro clássico é chamar de "icterícia do leite materno" um bebê de 1 mês com fezes claras. Cada semana perdida reduz a chance de o Kasai drenar a bile. Fezes claras ou icterícia depois de 2 semanas: **bilirrubina direta no mesmo dia** e encaminhamento urgente.

Cisto de colédoco

Dilatação congênita das vias biliares, mais em meninas e asiáticas. A tríade clássica (**dor, icterícia e massa** no hipocôndrio direito) aparece em poucos casos; é comum o diagnóstico por pancreatite ou colangite. Classificação de **Todani** (o tipo I, dilatação fusiforme ou cística do colédoco, é o mais comum). Tratamento: **resseção do cisto** e hepaticojejunostomia em Y de Roux, porque o cisto deixado aumenta o risco de colangiocarcinoma.

CAPÍTULO V

Defeitos da parede e do diafragma

TABELA 3. *Gastrosquise × onfalocele*

	GASTROSQUISE	ONFALOCELE
<i>Defeito</i>	Ao lado do cordão, quase sempre à direita	Central , no umbigo; o cordão sai do saco
<i>Cobertura</i>	Nenhuma : alças expostas, espessadas e endurecidas pelo líquido amniótico	Saco de membrana (âmnio e peritônio); pode conter fígado
<i>Anomalias associadas</i>	Poucas; a principal é a atresia intestinal	Frequentes : cardíacas, cromossômicas (trissomias 13, 18 e 21), síndrome de Beckwith-Wiedemann
<i>Mãe</i>	Jovem, tabagismo e drogas	Idade avançada
<i>Prognóstico</i>	Depende do intestino	Depende das anomalias associadas

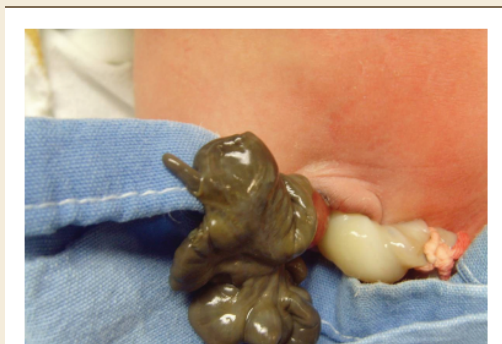


FIGURA 5. *Gastrosquise: alças expostas, espessadas e sem membrana, saindo ao lado de um cordão umbilical normal.*

Instituto Nacional de Pediatría (México), CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

CONDUTA · NA SALA DE PARTO

Gastrosquise: envolva as alças em **cobertura estéril e saco plástico** (protege e reduz a perda de calor e água), com a criança de lado para não dobrar o mesentério. Sonda gástrica, acesso venoso, hidratação generosa e aquecimento. **Não tente reduzir à força.** Depois, fechamento primário ou silo com redução gradual. **Onfalocele:** proteja o saco, investigue anomalias (eco, cariótipo) e controle a **glicemia** (Beckwith-Wiedemann).

Hérnia diafragmática congênita

Defeito no diafragma, em geral **posterolateral esquerdo** (Bochdalek), por onde as vísceras sobem para o tórax durante a gestação. O problema não é a hérnia: é o **pulmão hipoplásico** e a **hipertensão pulmonar**. Ao nascer: desconforto respiratório, abdome escavado, ruídos intestinais no tórax e coração desviado para a direita.

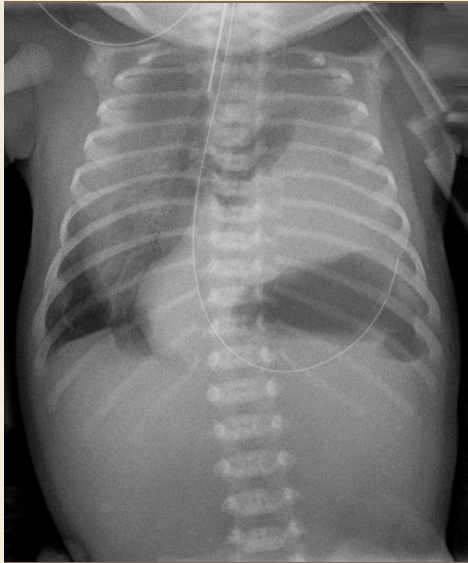


FIGURA 6. *Hérnia diafragmática esquerda: alças com ar ocupando o hemitórax esquerdo, coração e mediastino empurrados para a direita, e a ponta da sonda gástrica acima do diafragma.*

Hellerboff, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

CONDUTA · HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA

- **Não ventile com máscara e bolsa:** o ar vai para o estômago e as alças no tórax, que comprimem ainda mais o pulmão.
- **Intube** logo na sala de parto, com pressões baixas (ventilação gentil).
- **Sonda gástrica** em aspiração, para descomprimir as alças.
- Trate a hipertensão pulmonar e estabilize.
- A correção do defeito é **eletiva**, depois da estabilização: não é emergência cirúrgica.

CAI NA PROVA · OS TRÊS RECÉM-NASCIDOS DA SALA DE PARTO

Alças expostas sem membrana à direita do cordão: gastrosquise, saco plástico e de lado. **Saco central com o cordão saindo dele:** onfalocele, procurar anomalias e hipoglicemia. **Desconforto respiratório com abdome escavado:** hérnia diafragmática, intubar sem máscara e sonda gástrica.

Por que a criança não é um adulto pequeno

TABELA 4. *Diferenças que mudam a conduta cirúrgica*

CARACTERÍSTICA	CONSEQUÊNCIA
<i>Superfície corporal grande para o peso</i>	Perde calor e água rápido: aquecer sempre, cobrir vísceras expostas
<i>Reserva de glicogênio pequena</i>	Hipoglicemia em jejum: glicose na hidratação
<i>Hidratação calculada por peso</i>	Bolus e manutenção em mL/kg, nunca "um soro"
<i>Compensação hemodinâmica eficiente</i>	A pressão cai tarde; taquicardia e perfusão alteram antes
<i>Comunicação limitada</i>	A dor não localiza; o exame repetido vale mais que um exame isolado

CAPÍTULO VI

Virilha, umbigo e genitais

TABELA 5. Quando operar

CONDIÇÃO	O QUE É	CONDUTA
<i>Hérnia inguinal</i>	Quase sempre indireta : o conduto peritôniovaginal não fechou. Mais em prematuros e meninos	Sempre operar , de forma programada e sem demora (não regride, e o encarceramento é mais comum no 1º ano). No prematuro internado, o momento é individualizado com a anestesia. Ligadura alta do saco, sem reforço da parede
<i>Hidrocele não comunicante</i>	Líquido na túnica vaginal, tamanho constante, transilumina	Observar: a maioria some no 1º ano de vida
<i>Hidrocele comunicante</i>	Aumenta ao longo do dia ou com o choro: o conduto está aberto	Observar no 1º ano; operar se persistir, se houver hérnia associada ou dúvida sobre o testículo
<i>Hérnia umbilical</i>	Anel umbilical que não fechou; muito comum, sobretudo em crianças negras e prematuras	Observar: 88,6% fecham sozinhas até os 5 anos (coorte de 2024). Operar se persistir após essa idade, se encarcerar ou se for muito grande

ATENÇÃO · HÉRNIA INGUINAL ENCARCERADA

Sem sinais de estrangulamento (pele vermelha, toxemia, obstrução prolongada), tente a **redução manual** com a criança sedada; dá certo na maioria. Depois, opere na mesma internação, em 24–48 horas, quando o edema baixar. Com sinais de sofrimento, cirurgia de urgência. **Na menina**, a massa irreduzível pode ser o **ovário**, que torce sem dar sinais intestinais: não reduza às cegas, chame o cirurgião pediátrico.

Criptorquidia

Testículo que não está na bolsa e não desce com manobra. É o achado genital mais comum do recém-nascido, e muitos descem nos primeiros meses. **Testículo retrátil** (desce e fica) não é criptorquidia, mas pode subir de novo: examine todo ano até a puberdade.

CONDUTA · CRIPTORQUIDIA

- Encaminhar ao cirurgião se o testículo não desceu aos **6 meses** (idade corrigida no prematuro).
- **Orquidopexia** de preferência até os **12 meses**, no máximo até os 18 meses.
- Testículo não palpável: **laparoscopia**. Ultrassom antes do encaminhamento **não** é recomendado: não muda a conduta.
- Riscos: infertilidade, câncer, torção. Bilateral não palpável, ou com hipospádia: investigar **distúrbio da diferenciação sexual**.

Fimose e parafimose

No menino pequeno, o prepúcio que não retrai é **fisiológico**: as aderências se soltam sozinhas ao longo da infância. Não se deve retrair à força, porque as fissuras cicatrizam e criam uma fimose verdadeira.

TABELA 6. *Prepúcio: o que tratar*

SITUAÇÃO	CONDUTA
<i>Fimose fisiológica, sem sintomas</i>	Orientar higiene; não forçar
<i>Fimose com sintomas ou que persiste</i>	Corticoide tópico (por exemplo, betametasona) por 4 a 8 semanas: resolve a maioria
<i>Indicação de postectomia</i>	Falha do corticoide, fimose cicatricial (líquen escleroso), balanopostites de repetição, infecção urinária de repetição com anomalia urinária
<i>Parafimose</i>	Urgência : o prepúcio retraído estrangula a glândula. Redução manual imediata (compressão do edema e glândula empurrada para trás); se falhar, incisão dorsal

Hipospádia

O meato uretral abre na face **ventral** do pênis, entre a glândula e o períneo. O prepúcio fica incompleto, "em capuz" dorsal, e pode haver curvatura ventral. **Não faça postectomia**: o prepúcio pode ser usado na correção, feita entre 6 e 18 meses. Hipospádia com testículo não palpável pede investigação de distúrbio da diferenciação sexual.

Escroto agudo na criança

As três causas principais estão na apostila de Afecções Urológicas: **torção do testículo**, torção do apêndice testicular e epididimite. Na criança, vale lembrar:

- **Torção do testículo** tem dois picos: neonatal (torção extravaginal, muitas vezes já com testículo perdido ao nascer) e puberdade. A janela para salvar o testículo é de poucas horas. **Doppler normal não exclui torção**: a suspeita forte vai para a exploração cirúrgica sem esperar o exame.
- **Torção do apêndice testicular** é a causa mais comum entre 7 e 12 anos: dor no polo superior e, às vezes, o "ponto azul". Tratamento clínico.
- **Epididimite** na criança pequena é incomum: investigue anomalia do trato urinário.

CAI NA PROVA

Fimose fisiológica **não** se trata com cirurgia nem com retração forçada. Parafimose é urgência. Hipospádia **contraindica a circuncisão** antes da correção. Orquidopexia até 12–18 meses.

CAPÍTULO VII

Armadilhas e sequência mental

TABELA 7. Erros comuns

ERRO	POR QUE ESTÁ ERRADO
<i>Chamar vômito bilioso de refluxo</i>	Vômito verde no recém-nascido é obstrução; má rotação com volvo mata o intestino em horas
<i>Operar o piloro com alcalose</i>	Primeiro corrigir água, cloreto e potássio
<i>Esperar a "geleia de framboesa"</i>	É sinal tardio de sofrimento da alça
<i>Enema redutor com peritonite</i>	Peritonite, perfuração e choque contraindicam: cirurgia
<i>Fechar o diagnóstico de Hirschsprung pelo enema</i>	O diagnóstico é a biópsia retal
<i>"Icterícia do leite" com fezes claras</i>	Fezes claras = colestase = atresia de vias biliares até prova em contrário
<i>Máscara e bolsa na hérnia diafragmática</i>	Infla as alças no tórax; intubar e passar sonda
<i>Reduzir a gastrosquise à força na sala de parto</i>	Proteger com saco plástico e reduzir aos poucos depois
<i>Esperar a hérnia inguinal "fechar"</i>	Hérnia inguinal na criança não fecha; operar
<i>Pedir ultrassom para a criptorquidia</i>	Não muda a conduta e atrasa o encaminhamento
<i>Retrair o prepúcio à força</i>	Cria cicatriz e fimose verdadeira

A SEQUÊNCIA MENTAL EM 30 SEGUNDOS

- i.* Qual a idade? Recém-nascido, lactente, pré-escolar ou escolar: cada faixa tem suas causas.
- ii.* O vômito é bilioso? A dor é em crises? Há fezes claras, sangue ou atraso do mecônio?
- iii.* Está estável? Hidratar, aquecer, glicose e sonda gástrica antes de qualquer exame demorado.
- iv.* Escolha o exame que muda a conduta: ultrassom (piloro, intussuscepção, apendicite), radiografia (dupla bolha, pneumatose), seriografia (má rotação), biópsia (Hirschsprung).
- v.* Decida o tempo: emergência (volvo, torção, perfuração), urgência (intussuscepção, hérnia encarcerada) ou cirurgia programada (piloro corrigido, hérnia, criptorquidia).

COMPLEMENTO

Pontos clássicos de prova

Sinais, associações e números que as provas ainda cobram.

TABELA 8. O que mais cai

TEMA	PONTO DE PROVA	OBSERVAÇÃO
<i>Estenose do piloro</i>	Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica; "acidúria paradoxal" tardia	O rim troca potássio e hidrogênio para segurar sódio
<i>Dupla bolha</i>	Atresia duodenal; associação com síndrome de Down	Também pâncreas anular e membrana duodenal
<i>Sonda enrolada no tórax</i>	Atresia de esôfago; ar no estômago = fístula distal (tipo C)	VACTERL
<i>Íleo meconial</i>	Obstrução por mecônio espesso: fibrose cística	Radiografia com aspecto de "bolhas de sabão" na fossa ilíaca direita
<i>Sinal de Dance</i>	Fossa ilíaca direita "vazia" na intussuscepção	O ceco subiu com a invaginação
<i>Divertículo de Meckel</i>	Regra dos 2: 2% da população, 2 pés da válvula ileocecal, 2 tipos de mucosa ectópica	Sangramento indolor na criança; cintilografia com tecnécio
<i>Atresia de vias biliares</i>	Portoenterostomia de Kasai o mais cedo possível (melhor antes de 30–45 dias)	Principal indicação de transplante hepático pediátrico
<i>Hérnia diafragmática</i>	Bochdalek: posterolateral esquerda. Morgagni: anterior e rara	Hipoplasia pulmonar define o prognóstico
<i>Onfalocelo + macroglossia + hipoglicemia</i>	Síndrome de Beckwith-Wiedemann	Rastrear tumor de Wilms e hepatoblastoma
<i>Enterocolite necrosante</i>	Estadiamento de Bell: suspeita, confirmada (pneumatose), avançada	Pneumoperitônio é indicação cirúrgica
<i>Criptorquidia</i>	Orquidopexia até 12–18 meses	Testículo intra-abdominal: maior risco de câncer

Fontes: EAU Paediatric Urology; AUA (criptorquidia); CDH EURO Consortium; conferência com material de preparação para residência.

APÊNDICE

Referências

- Holcomb GW, Murphy JP, St. Peter SD (eds.). *Holcomb and Ashcraft's Pediatric Surgery*. 7ª ed. Elsevier; 2020.
- European Association of Urology. *EAU Guidelines on Paediatric Urology*: capítulos de testículo não descido, fimose, hidrocele, hipospádia e escroto agudo. Edição vigente, uroweb.org.
- Kolon TF et al. Evaluation and treatment of cryptorchidism: AUA guideline. *J Urol*. 2014;192(2):337–45.
- Snoek KG et al. Standardized postnatal management of infants with congenital diaphragmatic hernia in Europe: the CDH EURO Consortium consensus, 2015 update. *Neonatology*. 2016;110(1):66–74.
- He et al. Age and probability of spontaneous umbilical hernia closure. *JAMA Pediatr*. 2024;178(5).
- American College of Radiology. *ACR Appropriateness Criteria*: vômitos no lactente; suspeita de apendicite na criança.
- Brasil. Ministério da Saúde. *Caderneta da Criança* (escala de cor das fezes para detecção precoce da atresia de vias biliares).

CRÉDITOS DAS IMAGENS

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Pyloric-stenosis.jpg*: Dr Laughlin Dawes, CC BY-SA 4.0.
- *Duodenalatresie 0W - CR ap - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *Pneumosis intestinalis und hepatis bei NEC 0W - CR ap - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *Intussusception on ultrasound.jpg*: Frank Gaillard, CC BY-SA 3.0.
- *Captura de pantalla 2022-09-26 204202.png (recortada, sem a legenda original)*: Instituto Nacional de Pediatría México, CC BY-SA 4.0.
- *Kongenitale Zwerchfellhernie links - Roe ap 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 3.0.

ANOTAÇÕES
